UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de Pédagogie

Pédiatrie
Ictère du nouveau-né
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Léa JandinDate de rédaction : 25/01/2024

Situation de départ N° 48 – Ictère chez le nouveau-né

Domaine de compétence principal : Annonce

Domaine de compétence secondaire : Stratégie pertinente de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Rassurer les parents en cas d'ictère simple ou d'ictère au lait de mère

2- Expliquer aux parents les principes de la prise en charge de l'ictère du nouveau-né

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :

1. Ictère de l'adulte et de l'enfant
2. Allaitement maternel

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (entre 20 et 40 ans)

Matériel nécessaire à la station : OUI : Feuille avec l'observation médicale

Instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autre que ce qui est précisé.

Synopsis : Vous êtes jeune parent d'un nouveau-né de 6J et vous vous présentez aux urgences pédiatriques avec votre enfant car vous le trouvez « jaune » depuis les dernières 24h (doute confirmé par la sage-femme venue pour la pesée hebdomadaire). Un interne est déjà venu pour vous interroger et examiner votre enfant. Vous attendez que l'on vienne vous donner un diagnostic et qu'on vous explique la suite de la prise en charge.
(Aucun examen physique)

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Mme/Mr Février Age : 30 ans Profession : agent immobilièr(e) en congé maternité/paternité 1er enfant du couple Vit en appartement à Nice Enfant : Chloé Février 6j (seul enfant)
Antécédents de l'enfant	Grossesse sans complication Accouchement voie basse sans complication à 40SA +2 Poids de naissance 3550g et 50 cm Allaitement maternel exclusif
Médicaments / Toxiques	Pas de médicament Pas de toxiques : pas d'alcool, pas de cigarette
Etats d'esprit/ comportement	Anxiété : forte
Déroulement du scénario	Vous êtes assis(e) Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *« Je suis très inquièt(e), ce matin la sage-femme est passée à la maison et a trouvé que Chloé était jaune. Elle lui a fait un test sur la peau et nous a dit d'aller chez le pédiatre mais j'ai préféré venir ici directement. Un docteur est déjà venu nous voir mais il ne nous a rien dit ! Ça fait plus d'une heure qu'on attend. C'est grave c'est ça ? »* Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement

	2min avant la fin, si l'étudiant n'a pas encore abordé la prise en charge demander, inquiet : *« Mais Docteur, c'est grave ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que je dois arrêter de l'allaiter ? »*

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Est-ce que vous fumez ?	Non
Avez-vous consommé de l'alcool récemment (au cours de l'allaitement) ou lors de la grossesse ?	Non
Où vivez-vous ?	Dans un appartement à Nice
Que faites-vous dans la vie ?	Je suis agent immobilièr(e) en congé maternité/paternité
Prenez-vous des médicaments ?	Non
Avez-vous donné un médicament à votre enfant ?	Non
Avez-vous d'autres enfants ?	Non
Quel âge à Chloé ?	Elle a 6j
Avez-vous le carnet de santé de votre enfant ?	Non, je l'ai oublié
Depuis quand est apparu cet ictère/jaunisse ?	Ça fait moins de 24h que je l'ai remarqué
Chloé avait-elle déjà cette jaunisse/coloration à la maternité ?	Non
Chloé a-t-elle dû faire de la photothérapie à la maternité ?	Non, ça ne me dit rien
Comment vous êtes-vous rendus compte que votre fille était « jaune » ?	On trouvait qu'elle n'avait pas le même teint que la veille mais c'est la sage-femme qui nous a alerté quand elle est venue à la maison !

Est-ce que vous avez noté un changement dans le comportement de votre enfant ? Est-il moins éveillé ?	Non aucun changement
Votre enfant a-t-il moins d'appétit ?	Non Chloé mange bien comme les jours précédents
Y a-t-il eu des complications durant la grossesse ?	Non
L'accouchement s'est-il bien passé ?	Oui, il n'y a eu aucun problème, c'était un accouchement voie basse
Y a-t-il eu de la fièvre au moment de l'accouchement ? Une rupture de la poche des eaux > 12h ? Prélèvements vaginaux positifs pour Streptocoque de groupe B ?	Non
Chloé est-elle prématurée ?	Non
A quel terme a eu lieu l'accouchement ?	40SA +2
Comment est nourrie Chloé ? Est-ce un allaitement maternel ?	C'est un allaitement maternel exclusif
L'allaitement se passe-t-il bien ?	Oui très bien
Avez-vous eu des douleurs lors de l'allaitement ?	Non aucune douleur
Les selles de votre enfant sont-elles décolorées ?	Non
Les urines sont-elles foncées ?	Non
Connaissez-vous vos groupes sanguins ?	Oui, nous sommes tous les 2 de groupe A+
Y-a-t-il des maladies du sang dans la famille ? Sphérocytose ? Hémolyse ? Troubles de la coagulation ? Déficit en G6PD ?	Non
Le retour à la maison se passe-t-il bien ?	Oui pour l'instant nous n'avons pas eu de problème
Comment vous sentez-vous ?	Moi je me sens bien mais je suis très inquiet(e) pour mon enfant
Vous sentez-vous plus triste que d'habitude ?	Non

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne aux urgences pédiatriques et vous prenez en charge la petite Chloé pour ictère du nouveau-né.
Vous prenez connaissance du dossier informatique laissé par votre co-interne avant de vous présenter devant les parents. Vous allez voir la maman avec votre externe.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Justifier du caractère bénin de l'ictère

2. Expliquer la suite de la prise en charge

3. Aborder les bénéfices de l'allaitement maternel

Observation médicale de Chloé Février :

Nouveau-né de 6 jours présentant un ictère modéré apparu depuis moins de 24h.

Née à terme 40SA +2, par accouchement voie basse eutocique sans complication et sans risque d'infection néonatale bactérienne précoce. Grossesse sans anomalie.

Groupes sanguins des 2 parents A+. Pas de trouble de la coagulation connu dans la famille.

Poids de naissance 3550 g et poids de sortie de maternité 3450 g. Allaitement maternelle exclusif. Selles et urines de couleurs normales.

Cliniquement :

Bon état général.

Réflexes archaïques sans anomalie. Pas de trouble de la conscience. Pas de pâleur cutanéo-muqueuse. Pas d'ecchymose. Pas d'organomégalie.

Ictère modéré n'atteignant pas les plantes des pieds

Poids du jour 3545 g, bilirubinomètrie transcutanée 245 μmol/l (<75e percentile)

Diagnostic :

Ictère au lait maternel

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Annonce et réassurance parentale de l'ictère au lait de mère	
Annonce le diagnostic d'ictère au lait maternel	
Dit que l'ictère est apparu à J5/6 de vie	
Dit que la perte de poids n'est pas pathologique (< 8%)	
Dit que l'enfant n'est pas prématuré	
Dit que la clinique est rassurante ***(cite au moins 2/4)*** : - Ictère n'atteignant pas la plante des pieds - Pas de trouble de la conscience - Pas de signe d'hémolyse - Urines et selles normales	
Dit que la bilirubinémie transcutanée est < 75e percentile	
Informe du caractère bénin de l'ictère au lait de mère	
Informe sur la durée prévue de l'ictère de plusieurs semaines (*entre 4 et 6 semaines*)	
Expliquer aux parents les principes de la prise en charge de l'ictère du nouveau-né	
Dit qu'il n'y a pas d'examen complémentaire/biologie sanguine à réaliser	
Dit qu'il n'y a pas de traitement particulier à ce type d'ictère	
Informe sur la nécessité de reconsulter si l'état de leur enfant se dégrade <u>ou</u> si l'ictère n'a pas disparu après 6 semaines ***(cite au moins 1/2)***	
Dit que l'enfant ne sera pas hospitalisé	
Dit qu'il n'est pas utile d'arrêter l'allaitement maternel	
Aborder les bénéfices de l'allaitement	
Rappel les bienfaits de l'allaitement maternel pour la mère ***(cite au moins 3/6)*** : - Diminution risque cancer sein - Diminution risque de cancer ovaire - Diminution DT2 - Diminution obésité - Diminution la fréquence de la dépression post-partum - Diminution du risque de dyslipidémie, d'HTA et de maladie CV - Avantage financier	
Rappel les bienfaits de l'allaitement pour l'enfant ***(cite au moins 3/7)*** : - Diminution allergies et asthme - Diminution infections ORL - Diminution leucémies pédiatriques - Meilleur développement neuro-cognitif - Diminution du risque de malocclusion dentaire - Probable diminution du risque d'obésité et de diabète - Diminution de la mort subite	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	0 à 4
Aptitude à fournir les renseignements au patient/aux aidants	

Aptitude à écouter	
Communication non verbale	

Grille d'évaluation Aptitude à faire la synthèse des données

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

Grille d'évaluation Aptitude à fournir les renseignements au patient/aidant

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

Grille d'évaluation Aptitude à écouter

Grille d'évaluation Communication non verbale

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

Fiche de correction avec le barème

	Pondération entre 1 et 5
Annonce et réassurance parentale de l'ictère au lait de mère	
Annonce le diagnostic d'ictère au lait maternel	2
Dit que l'ictère est apparu à J5/6 de vie	3
Dit que la perte de poids n'est pas pathologique (<8%)	3
Dit que l'enfant n'est pas prématuré	3
Dit que la clinique est rassurante ***(cite au moins 2/4)*** : - Ictère n'atteignant pas la plante des pieds - Pas de trouble de la conscience - Pas de signe d'hémolyse - Urines et selles normales	3
Dit que la bilirubinémie transcutanée est < 75e percentile	3
Informe du caractère bénin de l'ictère au lait de mère	5
Informe sur la durée prévue de l'ictère de plusieurs semaines (entre 4 et 6 semaines)	2
Expliquer aux parents les principes de la prise en charge de l'ictère du nouveau-né	
Dit qu'il n'y a pas d'examen complémentaire/biologie sanguine à réaliser	3
Dit qu'il n'y a pas de traitement particulier à ce type d'ictère	3
Informe sur la nécessité de reconsulter si l'état de leur enfant se dégrade <u>ou</u> si l'ictère n'a pas disparu après 6 semaines ***(cite au moins 1/2)***	2
Dit que l'enfant ne sera pas hospitalisé	3
Dit qu'il n'est pas utile d'arrêter l'allaitement maternel	5
Aborder les bénéfices de l'allaitement	
Rappel les bienfaits de l'allaitement maternel pour la mère ***(cite au moins 3/6)*** : - Diminution risque cancer sein, - Diminution du risque de cancer ovaire, - Diminution DT2, - Diminution obésité, - Diminution la fréquence de la dépression post-partum - Diminution du risque de dyslipidémie, d'HTA et de maladie CV - Avantage financier	5
Rappel les bienfaits de l'allaitement pour l'enfant ***(cite au moins 3/7)*** : - Diminution allergies et asthme, - Diminution infections ORL, - Diminution leucémies pédiatriques, - Meilleur développement neuro-cognitif - Diminution du risque de malocclusion dentaire - Probable diminution du risque d'obésité et de diabète - Diminution de la mort subite	5

Note Totale	**/50**
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à fournir les renseignements au patient/aux aidants	1 à 5
Aptitude à écouter	1 à 5
Communication non verbale	1 à 5
NOTE TOTALE	**/70**